

 SCHINDLER INTENSIVPFLEGE	Mangelernährung	Qualitätshandbuch
		Geltungsbereich: alle

Definition:

Es können grundsätzlich zwei Formen der Mangelernährung unterschieden werden:

- Eine unzureichende Energiezufuhr (Unterernährung), etwa durch Hungern, sowie durch Krankheiten, die die Nährstoffaufnahme bzw. die Verstoffwechselung behindern (z.B. Morbus Crohn, Diabetes mellitus).
- Eine ausreichende Energiezufuhr, aber ein Mangel an Proteinen, Vitaminen und / oder Mineralien, etwa durch eine sehr einseitige Ernährung ohne frisches Obst und Gemüse (Mangelernährung).

Ursachen der Mangelernährung können sein:

Krankheiten, medikamentöse Therapie, Alterserscheinungen:

- akute und chronische Krankheiten, ggf. mit Schmerzzuständen
- Krankheiten, die mit dem Verlust kognitiver Fähigkeiten einhergehen, etwa Demenz
- Nebenwirkungen durch Medikamente, z.B. Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Geruchs- und Geschmacksveränderungen, Müdigkeit, Appetitlosigkeit
- körperliche Einschränkungen, etwa eine Halbseitenlähmung, Einsteifung einzelner Gelenke
- Erkrankungen, die zu einem erhöhten Energie- und Nährstoffbedarf bzw. zu einem erhöhten Flüssigkeitsbedarf führen, etwa Infektionen mit Fieber, Wundheilungsstörungen z.B. Dekubitus, Tumorerkrankungen, erhöhter Bewegungsdrang bei dementiellen Erkrankungen
- eingeschränkter Geruchs- und Geschmackssinn
- Schluckstörungen, schlechter Mund- und Zahnstatus

psycho-soziale Einschränkungen:

- Depression
- Mangel an sozialen Kontakten, soziale Isolation
- Ungünstig gelerntes und gelebtes Ernährungsverhalten durch Armut, Gewohnheit, Unwissen, Drogenabhängigkeit
- Ängste vor Allergien oder Unverträglichkeiten
- Wahnvorstellungen, etwa die Vorstellung, das Essen und die Getränke könnten vergiftet sein
- religiöse oder weltanschauliche Ernährungsgewohnheiten (etwa koscheres Essen im Judentum, vegetarische Ernährung, Verzicht auf Schweinefleisch bei Moslems)

ungeeignete Umgebungsfaktoren:

- Lärm bei Nahrungsaufnahme
- Unterbrechung der Mahlzeit
- unangenehme Gerüche

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2024		1	1/3	Verw./MA

 SCHINDLER INTENSIVPFLEGE an der Uniklinik Köln	Mangelernährung	Qualitätshandbuch
		Geltungsbereich: alle

- Ablehnung von Tischnachbarn
- keine flexiblen Essenszeiten
- mangelnde Unterstützung seitens des Personals
- fehlende Hilfsmittel, um eine selbständige Nahrungsaufnahme zu ermöglichen usw

Screening- und Assessmentinstrumente in unserer Einrichtung:

- Beim **Einzug** eines neuen Patienten oder **nach Krankenhausentlassung** wird eine fachliche Einschätzung zur Mangelernährung durchgeführt diese wird dann in der SIS niedergeschrieben
- Es wird 5 Tage lang ein Ernährungsplan (3053) geschrieben, um Auffälligkeiten und Problematiken zu erkennen. Auf dem Ernährungsplan ist ein Tellerschema abgebildet, mit dessen Hilfe man die verzehrte Portion (viertel, Hälfte, dreiviertel oder ganze Portion) kenntlich machen kann
- Geht aus der fachlichen Einschätzung hervor dass ein Risiko vorliegt, folgt eine **Fallbesprechung**, sie ist für das gesamte Team wichtig, jetzt werden weitere Maßnahmen geplant, es ist zu überlegen, ob ein Ernährungsplan anzulegen ist oder ob die auslösenden Faktoren ersichtlich sind und behoben werden können. Wichtig ist anschließend ein **Beratungsgespräch** mit dem Patienten oder den Angehörigen
- Geht aus der fachlichen Einschätzung hervor dass ein kein Risiko vorliegt, wird einmal monatlich das Gewicht erfasst, es sei denn es liegt eine ärztliche Verordnung vor. Eine erneute Einschätzung ist nur bei Veränderungen nötig
- Jeder Patient wird in unserer Einrichtung grundsätzlich einmal monatlich gewogen. Daraus ergibt sich ein aussagekräftiger Gewichtsverlauf. Unsere Pflegekräfte ermitteln dabei den sog. "BMI" (Body Mass Index). Die Aussagekraft dieses Systems wird allgemein anerkannt. Zur Ermittlung des BMI wird beim Einzug des Patienten die aktuelle Körpergröße erfasst und danach einmal jährlich erneut überprüft.
- Bei akuter Verschlechterung des Gesundheitszustandes, Gewichtsverlust von 5% in 1-3-Monaten oder ab einem BMI von 19 eines Patienten, wird in kürzeren Intervallen (1x wöchentlich) das Gewicht erfasst und ein Ernährungsplan geführt, um Änderungen des Essverhaltens zu erkennen, Maßnahmen werden eingeleitet(FB, Beratung, HA Info)
- Bei Patienten die Biografisch schon immer dünn waren, oder schon immer ein niedrigen BMI haben, sind keine großen Maßnahmen erforderlich, solange ihr gewohntes Essverhalten besteht. Auch hier wird erst bei massiven Änderungen oder Gewichtsverlust weitere Maßnahmen geplant

Aufstellung eines Ernährungsplans

- Der Ernährungsplan berücksichtigt kleinere aber dafür mehrere Portionen über den Tag verteilt.
- Er berücksichtigt die individuellen Ressourcen und Fähigkeiten des Patienten, z.B. wird einem Demenzkranken im fortgeschrittenen Stadium Fingerfood

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2024		1	2/3	Verw./MA

 SCHINDLER INTENSIVPFLEGE	Mangelernährung	Qualitätshandbuch
		Geltungsbereich: alle

angeboten und viel geschnittenes Obst und Gemüse, damit die Hemmschwellen für die Nahrungsaufnahme so gering wie möglich sind.

- Es werden Ziele gesteckt(Zielgewicht)
- Es wird der Gesamtenergiebedarf pro Tag errechnet, welcher auch erreicht werden sollte um Zielgewicht zu erreichen (Bsp. BW wiegt heute 45 kg und soll 50 kg erreichen, dann rechne ich mit 50kg den Energiebedarf aus)
- Maßnahmen werden erstellt und nach 3 Wochen ausgewertet und neu erhoben wenn nötig
- Mit der Küche werden die Maßnahmen abgesprochen und die Kcal auf den Tag verteilt

Darreichung des Essens

- PP achtet darauf, dass die einzelnen Komponenten (z.B. Gemüse, Fleisch, Kartoffeln) immer getrennt auf dem Teller sind.
- Das Essen wird nur in begründeten Fällen vollständig püriert. Daneben bieten wir weitere unterschiedliche Konsistenzstufen an.
- Wir servieren das Essen auf ansprechendem Porzellangeschirr.
- Da im Alter auch die Sinne schwächer werden, werden unsere Speisen mit Kräutern kräftig gewürzt, um den Geschmacks- und den Geruchssinn stärker anzuregen. Kräftige Farben der Lebensmittel und verschiedene Formen sorgen ebenfalls für eine Appetitsteigerung.
- Neben den drei Hauptmahlzeiten bieten wir selbstverständlich auch zwei bis drei Zwischenmahlzeiten an.

Störungsfaktoren werden abgestellt

- Ruhige Atmosphäre wird geschaffen ,kein unnötiger Lärm
- Benötigt ein Patient Anleitung oder Hilfe setzt sich die Pflegekraft mit an den Tisch
- Vorlieben und Abneigungen werden berücksichtigt
- Der Patient kann sich bei der Nahrungsaufnahme Zeit nehmen und wird nicht gedrängelt
- Wird das Essen gereicht, setzt sich die Pflegeperson neben den Patient, strahlt Ruhe aus
- Unterbrechungen bei Essen reichen sind zu vermeiden
- Verweigerungen werden akzeptiert, kein Patient wird zum essen gezwungen

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2024		1	3/3	Verw./MA